

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS DE CASCAVEL
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCÊNCIAS E SAÚDE – MESTRADO/
DOUTORADO

JOSÉ JOACY RABELO DE OLIVEIRA

**O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PESSOAS COM OBESIDADE NO SUS: UMA
EXPERIÊNCIA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ**

CASCAVEL-PR

2026

JOSÉ JOACY RABELO DE OLIVEIRA

**O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PESSOAS COM OBESIDADE NO SUS: UMA
EXPERIÊNCIA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde — Mestrado, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Biociências e Saúde

Área de concentração: Biologia, processo saúde-doença e políticas de saúde

ORIENTADOR: Professor Doutor Allan
Cezar Faria Araújo

CO-ORIENTADORA: Professora Doutora
Ligiane de Lourdes da Silva

CASCADEL-PR

2026

Rabelo de Oliveira, José Joacy
O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PESSOAS COM OBESIDADE NO SUS:
UMA EXPERIÊNCIA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ / José Joacy Rabelo
de Oliveira; orientador Allan Cezar Faria Araújo;
coorientadora Ligiane de Lourdes da Silva. -- Cascavel, 2026.
61 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Cascavel) --
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde, Programa de Pós-Graduação em
BioCiências e Saúde, 2026.

1. Tratamento da obesidade. 2. Equipe multiprofissional.
3. Atenção primária à saúde. I. Faria Araújo, Allan Cezar,
orient. II. da Silva, Ligiane de Lourdes, coorient. III.
Título.



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria

CNPJ 78.680.337/0001-84

Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário

Tel.: (45) 3220-3000 - www.unioeste.br

CEP: 85819-110 - Cx. P.: 701

Cascavel - PARANÁ



JOSÉ JOACY RABELO DE OLIVEIRA

O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PESSOAS COM OBESIDADE NO SUS: UMA EXPERIÊNCIA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde em cumprimento parcial aos requisitos para obtenção do título de Mestre em Biociências e Saúde, área de concentração Biologia, processo saúde-doença e políticas de saúde, linha de pesquisa Processo saúde-doença, **APROVADO** pela seguinte banca examinadora:

Documento assinado digitalmente
 **ALLAN CEZAR FARIA ARAÚJO**
Data: 06/03/2026 20:40:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Orientador - Allan Cezar Faria Araújo

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
 **ROSE MEIRE COSTA**
Data: 06/03/2026 18:38:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rose Meire Costa

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO JULIANO GRIGNET**
Data: 06/03/2026 12:11:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Juliano Grignet

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila)

Cascavel, 4 de março de 2026

BANCA EXAMINADORA

Orientador: Prof.. Dr.. Allan Cezar Faria Araújo

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.

Assinatura: _____

Co-orientador (se tiver): Prof.. Dra. Ligiane de Lourdes da Silva.

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.

Assinatura: _____

Membro: Prof.. Dr. Rodrigo Juliano Grignet.

Instituição: Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA.

Assinatura: _____

Membro: Prof.. Dr. Rose Meire Costa.

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.

Assinatura: _____

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho e todo esforço nele dedicado aos meus filhos: Lívia, Lucas e André, a quem direciono cada sentido da minha vida, dando a ela objetivo e alegria. Também a minha amada esposa Aline, por sua abnegação, amor e parceria.

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos a todos aqueles que me motivaram, direta ou indiretamente, por suas palavras e ações e, em especial, ao meu orientador, Dr. Allan Cezar Faria Araújo e a coorientadora Dra. Ligiane de Lourdes da Silva, amiga e conselheira.

RESUMO

Introdução: O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade constitui um dos principais desafios para a saúde pública contemporânea, comprometendo a qualidade de vida e sobrecarregando os sistemas de saúde. Nesse contexto, compreender o Itinerário Terapêutico (IT) de pessoas com obesidade encaminhadas para cirurgia bariátrica pode contribuir para melhorias práticas de cuidado e estratégias de acompanhamento multiprofissional. **Objetivos:** Analisar as características do IT de indivíduos com indicação para cirurgia bariátrica, atendidos por um serviço especializado de hospital público de ensino na região oeste do Paraná; descrever a situação atual da obesidade nos municípios que encaminham pacientes ao Serviço de Cirurgia e Obesidade Bariátrica (SCOB); avaliar a relevância do acompanhamento interdisciplinar no tratamento da obesidade; e identificar a percepção dos pacientes sobre facilitadores e barreiras encontradas ao longo do itinerário terapêutico pré-operatório. **Métodos:** Trata-se de um estudo de abordagem mista (qualitativa e quantitativa), fundamentado no método indutivo, com delineamento observacional de coorte e caráter longitudinal. Os dados quantitativos foram obtidos a partir das planilhas de acompanhamento dos usuários que participam do SCOB e analisados por meio do software Quantum GIS. Os dados qualitativos derivaram de entrevistas semiestruturadas com 19 participantes acompanhados durante 12 meses, comprovados segundo a técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin, com apoio do software TAMS Analyzer. **Resultados e Discussão:** A análise qualitativa permitiu conhecer a condição atual de obesidade do grupo estudado, seus aspectos clínicos e sociais. A partir da análise das entrevistas, foram identificadas cinco categorias temáticas: Hábitos alimentares contemporâneos; Atividade física no cotidiano digital; Emoções e auto imagem; Determinantes sociais de saúde e; Acesso ao cuidado em saúde. Após esta análise, podemos identificar erros e acertos no Itinerário Terapêutico, o que nos ajuda a refletir sobre quais medidas poderiam ser tomadas no aperfeiçoamento do tratamento dos pacientes obesos na região oeste do Paraná.

Palavras-chave: tratamento da obesidade; equipe multiprofissional; Atenção Primária à Saúde.

The Therapeutic Itinerary of People with Obesity in the Brazilian Public Health System (SUS): An experience in the western region of the Paraná

ABSTRACT

Introduction: The increasing prevalence of overweight and obesity constitutes one of the main challenges for contemporary public health, compromising health systems. In this context, understanding the therapeutic itinerary of obese individuals referred for bariatric surgery can contribute to improvements in care practices and multidisciplinary follow-up strategies. **Objectives:** To analyze the characteristics of the therapeutic itinerary of individuals indicated for bariatric surgery, attended by a specialized service of a public teaching hospital in the western region of Paraná; To describe current situation of obesity in the municipalities that refer patients to the bariatric surgery and obesity service; To evaluate the relevance of interdisciplinary follow-up in the treatment of obesity; And to identify patients' perceptions of facilitators and barriers encountered along the preoperative therapeutic itinerary. **Methods:** This is a mixed-methods study (qualitative and quantitative), based on the inductive method, with an observational cohort design and longitudinal character. Quantitative data were obtained from the monitoring spreadsheets of users participating in the bariatric surgery and obesity service and analyzed using Quantum GIS software. Qualitative data derived from semistructured interviews with 19 participants followed for 12 months, verified according to the content analysis technique proposed by Bardin, with the support of TAMS Analyser software. **Results and discussion:** the qualitative analysis allowed us to understand the current obesity status of the studied group, its clinical and social aspects. From the analysis of the interviews, five thematic categories were identified: contemporary eating habits; physical activity in daily digital life; emotions and self-image; social determinants of health; and access to health care. After this analysis, we can identify errors and success in the therapeutic itinerary, which helps us reflect on what measures could be taken to improve the treatment of obese patients in the western region of Paraná.

Keywords: Obesity treatment; Multidisciplinary team; Primary health care.

LISTA DE ABREVIATURAS

APS: Atenção Primária à Saúde
CEP: Conselho de Ética em Pesquisa
DCNT: Doença Crônica Não Transmissível
DEXA: Densitometria por Dupla Emissão de Raio-X
DM: Diabetes *Mellitus*
IMC: Índice de Massa Corpórea
IT: Itinerário Terapêutico
HAS: Hipertensão arterial sistêmica
HUOP: Hospital Universitário do Oeste do Paraná
LCSO: Linha de cuidado do sobrepeso e obesidade
PNAB: Política Nacional da Atenção Básica
RAS: Rede de Atenção à Saúde
RM: Ressonância Magnética
SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
SESA: Secretaria de Estado da Saúde/PR
SOCB: Serviço de Obesidade e Cirurgia Bariátrica
SUS: Serviço Único de Saúde
TC: Tomografia Computadorizada
TCC: Terapia Cognitivo Comportamental
TCLE: Termo de consentimento livre e esclarecido
Unioeste: Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UBS: Unidade básica de saúde
USF: Unidade de saúde da família
VAN: Vigilância Alimentar Nutricional

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	12
2. OBJETIVOS	14
2.1 Objetivo geral	14
2.2 Objetivos específicos	14
3. REFERENCIAL TEÓRICO	15
3.1 Abordagem multiprofissional: dilemas no tratamento da obesidade	16
3.2 Itinerário terapêutico da obesidade	18
3.3 Itinerário terapêutico da obesidade no oeste do Paraná	20
4. MÉTODO	22
4.1 Delineamento do estudo	22
4.2 Serviço de obesidade e cirurgia bariátrica (SOCB)	22
4.3 Amostra e critérios de seleção	24
4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão (etapa quantitativa)	24
4.3.2 Critérios de Inclusão (Etapa Qualitativa)	24
4.4 Procedimentos de análise estatística	24
4.4.1 Preparação e modelagem dos dados	24
4.4.2 Diagnósticos de robustez e ajuste	25
4.4.3 Análise de conteúdo temática e sistematização dos dados	25
5. ARTIGO	26
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	45
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48
APÊNDICE 1	52
ANEXO 1	53
ANEXO 2	57
ANEXO 3	58
ANEXO 4	59
ANEXO 5	60

1. INTRODUÇÃO

A obesidade constitui uma condição de saúde multifatorial e uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT), representa um dos maiores desafios à saúde pública global devido à sua prevalência elevada e às comorbidades associadas, como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes *mellitus* (DM) (Paraná, 2018). Projeções da Federação Mundial de Obesidade para 2030 estimam que metade da população mundial apresentará excesso de peso, com cerca de 1,1 bilhão indivíduos com obesidade (Índice de Massa Corporal — IMC ≥ 30 kg/m²). Tal cenário revela-se preocupante em países de renda média e baixa, cujos sistemas de saúde enfrentam sobrecarga por múltiplas demandas prioritárias (WOF, 2025).

No Brasil, considerando o fluxo de atendimento preconizado pelas Linhas de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade no SUS (LCSO), o manejo dos indivíduos com obesidade deve se iniciar na Atenção Primária à Saúde (APS), que funciona como porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), organizada em níveis de atenção. A APS é responsável pelo manejo inicial e quando necessário, pelo encaminhamento à Atenção Especializada (secundária) e posteriormente, à Atenção Hospitalar (terciária) (Brasil, 2020). O Itinerário Terapêutico (IT) configura-se como um processo dinâmico que abrange múltiplos serviços, profissionais e dimensões não institucionais — como terapias integrativas e práticas religiosas —, permitindo identificar barreiras, lacunas e potencialidades do cuidado ao indivíduo com obesidade desde a APS até a cirurgia bariátrica (Younes; Rizzotto; Araújo, 2017). A obesidade impõe ônus significativo aos sistemas de saúde, exigindo maior mobilização de recursos humanos especializados, consultas e procedimentos clínicos. No Brasil, as transformações socioeconômicas e alimentares nas últimas décadas contribuíram para a expansão contínua da doença, com mais da metade da população adulta acima do peso (Brasil, 2022). Trata-se uma condição multifatorial, resultante da interação complexa entre fatores genéticos, metabólicos, nutricionais e comportamentais (De Lorenzo, 2016). Para além do IMC, marcadores como circunferência abdominal, perfil lipídico e inflamatório são essenciais para a avaliação completa do risco individual (Paraná, 2020).

Diante dessa complexidade, exige-se resposta integrada ao manejo da obesidade. A abordagem deve ser voltada para a mudança no estilo de vida, com

intervenção dietética, prescrição medicamentosa, atividade física e terapia comportamental, favorecendo a redução de peso e a manutenção a longo prazo. Todavia, é essencial que essas estratégias sejam individualizadas, considerando as características físicas, metabólicas e psicossociais específicas de cada indivíduo (Silva *et al.*, 2025).

Para casos graves e refratários, a cirurgia bariátrica configura-se como método eficaz de tratamento da obesidade (Santos *et al.*, 2025). Por se tratar de um procedimento invasivo, implica maiores riscos e requer preparação pré-operatória minuciosa. Assim, a indicação cirúrgica requer avaliação criteriosa dos benefícios frente aos riscos potenciais de cada indivíduo, bem como da capacidade do paciente de adequar-se à nova realidade pós-cirúrgica (Medina *et al.*, 2025).

Diante do exposto, emerge o problema de pesquisa: Como se constitui o Itinerário Terapêutico de indivíduos encaminhados para cirurgia bariátrica em um hospital universitário do Oeste do Paraná, considerando os diferentes níveis de atenção à saúde e os desafios enfrentados ao longo desse percurso? Parte-se da hipótese de que, apesar da previsão de uma linha de cuidados articulada entre níveis de atenção no SUS, o IT dos pacientes encaminhados à cirurgia bariátrica revela fragilidades na integração dos serviços e desafios específicos no acesso, continuidade e qualidade do cuidado multiprofissional. Pressupõe-se ainda que tais fragilidades influenciam as experiências e percepções dos pacientes quanto ao tratamento da obesidade grave, impactando diretamente na adesão ao tratamento.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar as características do IT de indivíduos com indicação para cirurgia bariátrica, atendidos em hospital público de ensino da região oeste do Paraná.

2.2 Objetivos específicos

Realizar uma análise da situação atual da obesidade nos municípios da região oeste paranaense que encaminham pacientes ao Serviço de Obesidade e Cirurgia Bariátrica (SCOB);

Avaliar a relevância do acompanhamento multiprofissional no tratamento da obesidade;

Identificar a percepção dos indivíduos com obesidade sobre os facilitadores e as barreiras encontradas ao longo de seu itinerário terapêutico pré-operatório.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo a Federação Mundial de Obesidade (WOF), “mais de 17 milhões de pessoas com menos de 70 anos morreram de DCNT’s em 2021, e 11 milhões dessas mortes foram atribuídas a riscos evitáveis conhecidos [...]”, dentre os quais se destaca a obesidade (WOF, 2025, p. 24). De acordo com o Atlas Mundial de Obesidade 2025, as projeções para 2030 indicam que 50% da população mundial estará com excesso de peso, ou seja, com IMC igual ou superior a 25 kg/m². Desse total, estima-se que 17% dos homens e 22% das mulheres — o equivalente a 487 milhões e 643 milhões de indivíduos, respectivamente — apresentarão IMC maior ou igual a 30 kg/m², convivendo, portanto, com a obesidade.

No cenário brasileiro, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) indicam que 66,5% dos adultos apresentavam excesso de peso, dos quais 31,6% foram diagnosticados com obesidade. No estado do Paraná, os indicadores mostram-se ainda mais preocupantes: em 2020, o estado registava 69,9% da população adulta acima do peso, sendo 35,6% classificados como obesos (Paraná, 2022).

Essa elevação na prevalência está associada a múltiplos fatores, com destaque para o aumento do consumo de alimentos processados e ultra processados, ricos em gorduras saturadas e açúcares, a redução do nível de atividade física e alterações na composição da microbiota intestinal (Ribeiro *et al.*, 2025). Além disso, fatores genéticos e psicossociais desempenham papéis fundamentais na predisposição e no desenvolvimento da obesidade (Costa; Fontes; Rodrigues, 2020).

Neste sentido, autores brasileiros têm enfatizado a relevância do cuidado humanizado e integral no tratamento da obesidade. Tal perspectiva propõe que a pessoa seja assistida em sua totalidade, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também as dimensões emocionais e sociais (Pereira; Costa Filho, 2024).

No entanto, apesar de sua aplicabilidade clínica, o IMC apresenta limitações, pois não distingue a massa magra da massa gorda, nem mensura a distribuição da gordura corporal — um preditor crítico de risco metabólico. Por conseguinte, o uso de medidas complementares, como a circunferência abdominal, a relação cintura-quadril e a bioimpedância elétrica, tem sido recomendado para refinar o diagnóstico (Sousa, *et al.*, 2024).

Outras ferramentas, como a densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA), a ressonância magnética (RM) e a tomografia computadorizada (TC), proporcionam avaliações mais acuradas da composição corporal. Contudo, devido à complexidade técnica e ao elevado custo, tais exames não são utilizados rotineiramente na prática clínica, tampouco encontram-se amplamente disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) (Lee *et al.*, 2018).

Além das medidas antropométricas, também é importante avaliar os fatores de risco associados à obesidade, incluindo Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), dislipidemia, resistência à insulina, síndrome metabólica e apneia do sono. Para isso, são necessários exames laboratoriais e clínicos complementares (Silva *et al.*, 2025). Vale ressaltar que o diagnóstico da obesidade deve considerar não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos psicológicos e sociais. Transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade, são comuns em indivíduos obesos e podem dificultar o tratamento da condição (Pereira; Costa Filho, 2024).

Este panorama reforça a necessidade de atualização e capacitação dos profissionais de saúde, bem como da estruturação das Redes de Atenção à Saúde (RAS). O investimento governamental, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS) e na Atenção Especializada, é vital para aumentar a resolutividade do cuidado. Conter o avanço da obesidade exige um esforço conjunto entre academia, profissionais, gestores e sociedade civil, visando mitigar os impactos sobre a saúde pública e a sobrecarga do sistema de saúde brasileiro.

3.1 Abordagem multiprofissional: dilemas no tratamento da obesidade

A obesidade é uma condição de saúde multifatorial caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, o que compromete a integridade sistêmica do indivíduo. Por ser uma doença crônica de etiologia complexa — envolvendo determinantes genéticos, metabólicos, comportamentais e ambientais —, pressupõe-se uma abordagem igualmente multifocal. Nesse sentido, o itinerário terapêutico (IT) apropriado deve contemplar não apenas o atendimento multidisciplinar, mas uma estratégia abrangente e integrada (Brasil, 2021).

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) deve estar presente “ao identificar de forma precoce algum desvio ou comportamento de risco para o desenvolvimento do excesso de peso e obesidade [...]” (Brasil, 2021). A VAN utiliza instrumentos que visam identificar padrões alimentares prejudiciais — como o tipo de alimento

consumido, o tempo dedicado às refeições e o ambiente onde ocorrem — e deve ser priorizada pela APS em todos os pontos de contato com o usuário.

Com base nessas informações, é possível gerar dados a fim de organizar fluxos, demandas e a necessidade de encaminhamento ao profissional nutricionista, cuja atuação é primordial no tratamento da obesidade. Este profissional é responsável por realizar uma avaliação nutricional completa do paciente, considerando suas necessidades individuais, hábitos alimentares, nível de atividade física e preferências alimentares. Os nutricionistas planejam, implementam e acompanham a efetividade de um plano de cuidado personalizado. Este plano envolve a prescrição de uma dieta equilibrada e adequada, que visa à perda de peso de maneira saudável, sustentável, e a promoção de uma reeducação alimentar duradoura (Assis *et al.*, 2019).

Complementarmente, os médicos, especialmente os endocrinologistas, possuem papel fundamental no manejo da obesidade. Esses especialistas são responsáveis pelo diagnóstico e tratamento de patologias endócrinas que podem contribuir para o ganho ponderal, como o hipotireoidismo, além de avaliarem a necessidade de intervenções farmacológicas para o controle do peso. Um estudo conduzido por Mancini *et al.* (2017) ilustrou que a abordagem combinada de dieta, exercício físico e farmacoterapia é eficaz na redução do peso corporal e na melhoria dos marcadores metabólicos.

O suporte psicológico é igualmente crucial na equipe de saúde. Psicólogos auxiliam o paciente a compreender e manejar aspectos emocionais e comportamentais que influenciam o peso, tais como estresse, ansiedade e depressão. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) tem demonstrado eficácia na promoção de mudanças duradouras no estilo de vida. Palmeira *et al.* (2017) destacam a importância da TCC na manutenção do peso perdido e no desenvolvimento de uma relação mais equilibrada com a alimentação (Ribeiro *et al.*, 2025).

O papel dos educadores físicos também é fundamental no tratamento da obesidade. Eles prescrevem e orientam a prática de atividades físicas, adaptadas às condições e às preferências individuais dos pacientes. A prática regular de atividades físicas é um dos pilares do tratamento da obesidade, auxiliando na perda de peso e na manutenção da perda de peso a longo prazo. Isto é reforçado pelo Ministério da Saúde do Brasil em seu Guia de Atividade Física para a População Brasileira (Brasil, 2021).

Para Mendes *et al.* (2025), a abordagem multidisciplinar no tratamento da obesidade é de extrema importância, uma vez que a obesidade é uma condição

complexa que envolve diversos fatores. A atuação conjunta de profissionais de diferentes áreas permite uma abordagem mais completa e eficaz do problema. Contudo, essa abordagem tende a ser mais individualista. Nesse contexto, a atuação multiprofissional parece mais eficiente.

No Brasil, diversos protocolos de intervenção multiprofissional têm sido implementados, a exemplo da Linha de Cuidados para Sobrepeso e Obesidade da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Paraná, 2022). Esses protocolos refletem a necessidade de padronização dos serviços e adaptação das estratégias às realidades socioculturais e econômicas locais, engajando diferentes disciplinas em um atendimento sistematizado, colaborativo e centrado no paciente.

É importante ressaltar que o sucesso terapêutico não depende exclusivamente da equipe técnica; o envolvimento do paciente e de sua rede de apoio familiar é crucial. A adoção de um estilo de vida saudável exige motivação intrínseca e suporte social contínuo. Em última análise, a abordagem multiprofissional constitui uma estratégia necessária para o enfrentamento da obesidade, impactando diretamente na saúde pública e na qualidade de vida (Mendes *et al.*, 2025).

3.2 Itinerário terapêutico da obesidade

O Itinerário Terapêutico (IT) é definido por França e Pereira (2024, p. 3) como “[...] o caminho percorrido pelo indivíduo e sua rede de apoio na busca da recuperação da saúde [...]”. Este percurso é multidimensional, abrangendo desde o tratamento convencional no sistema biomédico até práticas integrativas e determinantes sociais, como a utilização de fitoterapia, acupuntura ou suporte espiritual. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Primária à Saúde (APS) constitui o ponto de partida essencial para o manejo clínico (BRASIL, 2020). Todavia, as comorbidades associadas e o caráter inflamatório da obesidade frequentemente demandam recursos tecnológicos que transcendem a capacidade resolutive das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A compreensão da necessidade de tratamento é o passo inicial para o enfrentamento da patologia. Na APS, está prevista uma abordagem multidisciplinar que, embora por vezes limitada em densidade tecnológica, é fundamental para o acompanhamento longitudinal da condição (Mendes *et al.*, 2025). Contudo, devido ao foco na baixa complexidade, as intervenções iniciais podem revelar-se insuficientes quando o quadro clínico apresenta exigências superiores, como exames de imagem

específicos ou avaliações de maior profundidade diagnóstica (Brasil, 2020).

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), normativa que regulamenta a APS, estabelece que as equipes das UBS devem ser compostas, no mínimo, por médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Nas Unidades de Saúde da Família (USF), a equipa é ampliada com profissionais de saúde bucal e médicos especializados em Saúde da Família e Comunidade (Brasil, 2020). Embora essa composição seja robusta para o atendimento primário, situações clínicas complexas exigem suporte da Atenção Especializada para garantir um manejo integral (Younes; Rizzotto; Araújo, 2017).

Neste contexto, caso o paciente necessite de intervenções de maior densidade, deve ser referenciado para o nível secundário das Redes de Atenção à Saúde (RAS). A "Linha de Cuidado às Pessoas com Sobrepeso e Obesidade" do Paraná salienta que o cuidado compartilhado multiprofissional — envolvendo idealmente nutricionistas, psicólogos e profissionais de educação física — contribui para resultados mais significativos (Paraná, 2022). O serviço especializado é realizado em ambulatórios próprios ou consórcios intermunicipais. Na atenção especializada, os profissionais utilizam tecnologias leve-duras para aprofundar o tratamento dentro das suas competências específicas.

Especialistas como endocrinologistas, cardiologistas e ortopedistas conduzem o acompanhamento por períodos prolongados para avaliar a progressão e ajustar as condutas terapêuticas. Havendo resposta satisfatória, o paciente deve ser contrarreferenciado para a APS para seguimento. Inversamente, se houver refratariedade ao tratamento e risco iminente de complicações graves, indica-se o encaminhamento ao nível terciário (hospitalar), onde a cirurgia bariátrica surge como possibilidade terapêutica (Younes; Rizzotto; Araújo, 2017).

O Ministério da Saúde, no "Manual de Atenção às Pessoas Com Sobrepeso e Obesidade no Âmbito da APS", define como ações prioritárias (Brasil, 2021):

- Aconselhamento para introdução da alimentação complementar na infância;
- Estímulo à adoção de hábitos de vida saudáveis (alimentação adequada e atividade física);
- Promoção e apoio ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e continuado até os 2 anos;
- Prevenção, identificação e tratamento de distúrbios nutricionais em todos os ciclos de vida;

- Manejo de condições endocrinológicas prevalentes, como hipotireoidismo e dislipidemias.

O documento reconhece a complexidade do tratamento e reforça a necessidade de favorecer a integralidade da atenção. No entanto, embora oriente a articulação regional para a regulação de vagas e exames, o manual não especifica parâmetros quantitativos sobre o quadro de profissionais necessário para suprir a demanda real, o que pode tornar a estrutura prevista na PNAB insuficiente frente às necessidades locais (Brasil, 2020; 2021).

3.3 Itinerário terapêutico da obesidade no Oeste do Paraná

A região Oeste do Paraná caracteriza-se por sua produção agrícola; pela localização estratégica na Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e o Paraguai e por uma densa pluralidade étnica que se reflete na culinária e nos hábitos culturais locais (Paraná, 2022). Sob a ótica da organização sanitária, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) divide a Macrorregião Oeste em três Regionais de Saúde (9ª, 10ª e 20ª RS), que congregam 52 municípios e aproximadamente 1,3 milhão de habitantes, representando mais de 12% da população estadual (Paraná, 2023).

Em conformidade com a Lei nº 8.080/1990, que estabelece a descentralização como princípio organizativo do SUS, os municípios possuem autonomia para gerir a Atenção Primária à Saúde (APS) e elaborar estratégias de enfrentamento às necessidades sanitárias locais. Na prática, a gestão municipal detém a atribuição de determinar as frentes de combate à obesidade, seja pela criação de programas próprios ou pela adesão a diretrizes estaduais e federais, além da responsabilidade pela contratação de pessoal e alocação de recursos financeiros (Barbos; Solléro; Recine, 2024).

Contudo, Lordani (2019) salienta que, apesar dos avanços científico-tecnológicos no tratamento da obesidade, os serviços de saúde carecem de profissionais em quantitativo e qualificação adequados, especialmente no âmbito da APS. Tal escassez pode derivar da subestimação da demanda, de limitações financeiras ou da baixa visibilidade do problema como patologia crônica. Essas deficiências geram lacunas assistenciais, fragmentação dos encaminhamentos e uma fragilização na padronização da oferta, resultando em fluxos assistenciais confusos tanto para usuários quanto para profissionais.

No plano estadual, a "Linha de Cuidado às Pessoas Com Sobrepeso e

Obesidade: adulto" visa estimular o desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e vigilância nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) (Paraná, 2022). Embora o Ministério da Saúde forneça linhas-guia nacionais com enfoque multiprofissional (Brasil, 2021), tais documentos não possuem caráter impositivo devido à autonomia federativa. Consequentemente, observa-se uma disparidade entre as recomendações teóricas e a assistência efetivamente ofertada, gerando itinerários terapêuticos heterogêneos entre os municípios da região.

De forma sintetizada, a SESA estabelece que o fluxo de atendimento deve iniciar-se na APS, com manejo clínico de pelo menos dois anos antes de qualquer progressão para níveis de maior complexidade. Caso as possibilidades terapêuticas convencionais se esgotem sem a estabilização do paciente, a cirurgia bariátrica surge como alternativa. Entretanto, esta intervenção é considerada o último recurso, dado o seu caráter invasivo e os elevados custos financeiros e psicossociais envolvidos (Paraná, 2022).

A implementação dessas linhas de cuidado, assim como já ocorre com a Rede Mãe Paranaense e o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) para Hipertensão e Diabetes, depende da viabilidade técnica e financeira de cada gestão municipal (Paraná, 2018a; 2018b). Diante desse cenário, emergem questionamentos fundamentais: uma equipe multiprofissional mais robusta na APS poderia mitigar o encaminhamento precoce à cirurgia bariátrica? Qual a influência de um IT estruturado nos moldes das Linhas de Cuidado sobre o prognóstico pós-operatório desses pacientes?

Compreender essas questões é vital para fortalecer as potencialidades do IT no Oeste paranaense. O perfil regional revela uma demanda reprimida considerável por cirurgias bariátricas, o que expõe as fragilidades do sistema, como o contingenciamento de recursos e a sobrecarga da APS. Portanto, a análise criteriosa do itinerário disponibilizado na região é indispensável para evitar injustiças assistenciais e promover intervenções mais ajustadas à realidade local (Lordani, 2019).

4. MÉTODO

Apresenta-se, neste capítulo, a caracterização da pesquisa desenvolvida no âmbito desta dissertação de mestrado, bem como o percurso metodológico adotado. São detalhadas as etapas da investigação, fundamentadas na coleta de dados junto ao Serviço de Obesidade e Cirurgia Bariátrica (SOCB) do HUOP/UNIOESTE, além dos procedimentos éticos e técnicos utilizados para a sistematização e interpretação das informações obtidas.

4.1 Delineamento do estudo

Esta investigação caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem mista (quali-quantitativa), fundamentada no método indutivo e com delineamento retrospectivo observacional e de coorte. A análise quantitativa fundamentou-se em dados de participantes do SOCB, extraídos de planilhas de acompanhamento mensal, contemplando variáveis como peso, tempo de convivência com a obesidade, hábitos alimentares e níveis de atividade física e acesso ao acompanhamento pela APS.

Paralelamente, a etapa qualitativa consistiu em entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas integralmente para análise posterior, utilizando como guia um roteiro temático (Apêndice 1). Para assegurar o anonimato, os sujeitos foram identificados por códigos numéricos (Paciente 1, 2, 3...), conforme a ordem cronológica das entrevistas. Os registros em áudio e as respectivas transcrições foram armazenados em dispositivos protegidos por criptografia de senha.

A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unioeste sob o parecer nº 7.199.464, em 1º de novembro de 2024 (Anexo 3), e todos os procedimentos iniciaram-se apenas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

4.2 Serviço de obesidade e cirurgia bariátrica (SOCB)

O estudo foi conduzido no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), unidade hospitalar vinculada à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste, 2024), caracteriza-se como um hospital de ensino de grande porte (355 leitos) e referência em alta complexidade. Sua área de abrangência compreende as 9ª, 10ª e 20ª Regionais de Saúde, totalizando 52 municípios que compõem a Macrorregião

Oeste, o que representa um contingente populacional superior a 1,3 milhão de pessoas (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 2024).

Inserido nesta estrutura, desde 2013, o SOCB, desenvolve como um grupo de atendimento multiprofissional. A equipe é composta por assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e psicólogos, além de integrar acadêmicos e pós-graduandos. Por estar vinculado ao HUOP/UNIOESTE, o SOCB cumpre a função indissociável de assistência, ensino e pesquisa, oferecendo atendimento integral e gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O serviço recebe pacientes referenciados pela Atenção Primária à Saúde (APS) e pela atenção especializada que aguardam a cirurgia bariátrica como parte do itinerário terapêutico. O objetivo central do SOCB é preparar os usuários para a intervenção cirúrgica, focando em mudanças comportamentais essenciais, como a prática de atividade física, reeducação alimentar, autopercepção, aceitação e manejo farmacológico. Tais intervenções visam assegurar uma adaptação adequada à nova realidade metabólica e psicossocial no período pós-operatório.

Os atendimentos são estruturados em grupos de aproximadamente 50 pacientes, com ingressos semestrais. Os encontros ocorrem mensalmente, de forma sistemática, permitindo o acompanhamento da evolução individual e coletiva. Ao final do protocolo de preparação, os pacientes que demonstram adesão e estabilidade clínica são submetidos à intervenção cirúrgica, enquanto os demais são contrarreferenciados para a continuidade do cuidado na rede básica de saúde.

Neste ambiente de cooperação mútua, os profissionais alternam-se nas apresentações, nos planejamentos e nas intervenções, mantendo o foco na integralidade do atendimento ao paciente obeso e à sua rede de apoio familiar. Sob a ótica da atuação multiprofissional, são estabelecidas metas exequíveis, acompanhando-se o progresso individual com ênfase na autonomia e no protagonismo do sujeito. Após o ciclo de preparação — que possui duração média de um ano — os pacientes que apresentam a devida indicação clínica e adesão ao protocolo são submetidos à cirurgia bariátrica. Por outro lado, aqueles que não aderem ao programa ou que alcançam controle metabólico sem a necessidade de intervenção invasiva são contrarreferenciados para a continuidade do acompanhamento longitudinal na Atenção Primária à Saúde (APS).

4.3 Amostra e critérios de seleção

A população foi constituída por todos os indivíduos que iniciaram os acompanhamentos, na modalidade de atendimento coletivo no SOCB, entre setembro de 2024 e agosto de 2025. A seleção da amostra foi segmentada conforme a natureza dos dados (quantitativos e qualitativos).

4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão (etapa quantitativa)

Para a extração e análise dos dados quantitativos provenientes da base de dados do SOCB, estabeleceram-se os seguintes critérios:

Inclusão: (i) participantes integrantes do grupo iniciado em setembro de 2024 (II/2024); (ii) preenchimento completo do questionário de anamnese (Anexo 1); (iii) idade igual ou superior a 18 anos.

Exclusão: (i) indivíduos não pertencentes à coorte iniciada em setembro de 2024 (II/2024); (ii) recusa ou ausência de dados no questionário de anamnese; (iii) indivíduos menores de 18 anos.

4.3.2 Critérios de Inclusão (Etapa Qualitativa)

A amostra qualitativa foi composta por 19 participantes, selecionados mediante os critérios: (i) residência em Cascavel ou municípios adjacentes; (ii) faixa etária entre 18 e 60 anos; (iii) diagnóstico de sobrepeso ou obesidade confirmado por prontuário; e (iv) aceite voluntário via assinatura do TCLE. Buscou-se a intencionalidade na seleção para garantir a heterogeneidade quanto ao sexo, escolaridade e ocupação.

4.4 Procedimentos de análise estatística

Os dados quantitativos, oriundos da ficha de anamnese e dos acompanhamentos regulares, pertencentes ao SOCB, contemplaram variáveis físicas, histórico clínico, estilo de vida (sono, rotina, medicamentos) e avaliações multiprofissionais (odontológica e psicológica).

4.4.1 Preparação e modelagem dos dados

A análise seguiu um rigoroso protocolo de limpeza e categorização de variáveis. A análise estatística foi processada no *software* R (versão 4.3.2), utilizando os pacotes *tidyverse* para tratamento e *stats* para modelagem. O estudo empregou duas abordagens complementares:

A. Regressão Logística Binária: Utilizada para identificar fatores associados à presença de obesidade (variável dependente sexo, idade, escolaridade, ocupação, atividade física, comorbidades, etc.).

B. Regressão Linear Múltipla: Aplicada para avaliar a variação do IMC em escala contínua, permitindo uma análise de gradiente: IMC, sexo, idade, escolaridade, ocupação, atividade física, comorbidades.

As variáveis foram inseridas em blocos hierárquicos (sociodemográficos, ocupacionais e comportamentais), fundamentados no arcabouço de determinantes sociais da saúde da Organização Mundial da Saúde (World Health Organization, 2025).

4.4.2 Diagnósticos de robustez e ajuste

Para assegurar a validade das inferências, realizaram-se os seguintes testes:

A. Multicolinearidade: Avaliada pelo Fator de Inflação da Variância ($VIF < 5$).

B. Homocedasticidade e Normalidade: Testes de *Breusch-Pagan* e *Shapiro-Wilk*, respectivamente. Ajuste do Modelo Logístico: Teste de *Hosmer-Lemeshow* para calibração e análise da área sob a curva ROC (AUC) para discriminação (Hosmer; Lemeshow; Sturdivant, 2013).

C. Significância: Adotou-se o intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Interações como *sexoidade** e *escolaridadeocupação** foram mantidas apenas quando contribuíram para o ajuste global conforme o critério de parcimônia.

4.4.3 Análise de conteúdo temática e sistematização dos dados

Os dados foram sistematicamente organizados e analisados sob a perspectiva da Análise de Conteúdo (Bardin, 2016 *apud* Valle; Ferreira, 2025). Para o processamento do *corpus* textual derivado das transcrições, utilizou-se o suporte computacional do *software* RQDA (pacote do sistema R para análise qualitativa) e do TAMS *Analyzer*. Essas ferramentas possibilitaram a codificação multivariada, a organização das unidades de registro e a identificação das categorias temáticas de forma transparente e rigorosa.

A interpretação sistemática das narrativas buscou a categorização dos dados em dimensões como: fatores socioeconômicos e culturais; rede de apoio; e aspectos institucionais. Essa estrutura permitiu compreender como o IT de cada participante

contribuiu para sua condição de saúde atual e para o manejo da obesidade no contexto regional.

5. ARTIGO

Artigo submetido a Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento – RBONE (Anexo 4), conforme normas desta revista (Anexo 5).

FRAGMENTAÇÃO, ESTIGMA E DESIGUALDADES: O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PESSOAS COM OBESIDADE NO SUS

Fragmentation, stigma and inequalities: the therapeutic itinerary of people with obesity in Brazil's Unified Health System

OLIVEIRA, José Joacy Rabelo de¹

SILVA, Ligiane de Lourdes da²

COSTA, Rose Meire³

ARAÚJO, Allan Cezar Faria⁴

Introdução: A obesidade impõe desafios à organização do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no que se refere à coordenação entre os diferentes níveis de atenção. A análise do itinerário terapêutico (IT) constitui uma estratégia relevante para compreender como os usuários vivenciam o atendimento na Rede de Atenção à Saúde (RAS). **Objetivo:** Analisar o IT de indivíduos obesos atendidos em um serviço especializado, identificando barreiras e facilitadores ao acesso e à continuidade do cuidado no SUS. **Materiais e Métodos:** Método misto, convergente e de corte transversal, realizado em um serviço especializado de um hospital universitário localizado no Oeste do Paraná, Brasil. A amostra é composta por 19 participantes, acompanhados por equipe multiprofissional. Dados quantitativos foram

1 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) - Campus de Cascavel - PR. E-mail: jjuniorrabelo4@gmail.com

2 Docente, Dra. no Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêutica do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) - Campus de Cascavel - PR. E-mail: ligiane.silva@unioeste.br

3 Docente, Dra. no Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) - Campus de Cascavel - PR. E-mail: rosecb@gmail.com

4 Docente, Dr no Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) - Campus de Cascavel - PR. E-mail: allancfaraujo@uol.com.br

coletados a partir de prontuários e registros em planilhas e analisados por meio de estatística descritiva e de regressão logística. As entrevistas foram submetidas à Análise de Conteúdo, conforme Bardin, integrando os resultados quantitativos e qualitativos na etapa interpretativa. **Discussão:** Identificou-se associações significativas entre obesidade determinantes sociais, com destaque ao forte impacto dos trabalhos sedentários. **Resultados:** O IT mostrou-se prolongado, com tempo médio de 5,8 anos entre o início e o acesso ao serviço especializado e inúmeras interrupções nos encaminhamentos e falhas na assistência. Coube ao serviço especializado articular o IT. **Conclusão:** A trajetória percorrida pelos usuários revelou-se um fenômeno socialmente construído, marcado pela fragmentação e pelas desigualdades. Demonstrando deficiências na articulação da RAS, indicando a necessidade de reorganizar a linha de cuidado à obesidade, orientada pelos princípios da integralidade e da equidade.

Palavras-chave: Obesidade; Itinerário Terapêutico; Sistema Único de Saúde; Determinantes Sociais da Saúde; Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT

Introduction: Obesity poses challenges to the organization of care within Brazil's Unified Health System (SUS), particularly regarding coordination across different levels of care. The analysis of the therapeutic itinerary (TI) is a relevant strategy to understand how users experience, in practice, the fragmentation of the RAS. **Objective:** To analyze of the TI of individuals with obesity treated in a specialized service, identifying barriers and facilitators to access and continuity of care within SUS. **Materials and Methods:** A mixed-methods study, convergent and cross-sectional study was conducted in a specialized service of a university hospital in western Paraná, Brazil. The sample consisted of 19 participants, follow-up by a multidisciplinary team. Quantitative data were collected from medical and spreadsheets, subsequently analyzed using descriptive statistical and logistic regression. The interviews were subjected to Content Analysis, according to Bardin, integration quantitative and qualitative results in the interpretative stage. **Discussion:** Significant associations were identified between obesity and social determinants, highlighting the strong impact of sedentary work. **Results:** The treatment pathway proved to be prolonged, with an average of 5.8 years between the onset accesses to specialized services, and numerous interruptions in referrals and failures in care. The specialized service was responsible for coordinating the treatment pathway. **Conclusion:** The trajectory followed by users revealed itself to be a socially constructed phenomenon, marked by fragmentation and inequalities. It demonstrates deficiencies in the articulation of the healthcare network, indicating the need to reorganize the obesity care pathway guided by the principles of comprehensiveness and equity.

Keywords: Obesity treatment; Content analysis; Multidisciplinary care.

Introdução

A obesidade caracteriza-se como uma doença crônica não transmissível (DCNT) de etiologia multifatorial e configura-se como um dos maiores desafios para a saúde pública global, dada sua prevalência crescente e preocupante (World Obesity Federation, 2025). No Brasil, o manejo dessa condição complexa é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Rede de Atenção à Saúde (RAS), que organiza ações e serviços de acordo com diferentes níveis de densidade tecnológica (Brasil, 2020).

A principal porta de entrada é a Atenção Primária à Saúde (APS), operacionalizada nos postos de saúde, responsáveis pela organização e regulação do fluxo de usuários na rede. Dentro da RAS, os usuários podem ser encaminhados a serviços especializados: Atenção Especializada (secundária), voltada a situações mais complexas, e Atenção Hospitalar (terciária), destinada a intervenções urgentes, de emergência e outras de alta complexidade, como cirurgias. Contudo, a fragmentação e a insuficiente coordenação do cuidado permanecem como desafios estruturais, frequentemente marcados pela descontinuidade e pela priorização de procedimentos em detrimento do plano terapêutico (Giovanella e Mendes, 2020).

O percurso realizado pelos indivíduos ao longo do tempo, por diferentes pontos de atenção, é denominado Itinerário Terapêutico (IT). Mais do que uma sequência de consultas, o IT configura-se como um processo dinâmico e singular, que envolve a coordenação — muitas vezes imperfeita — entre múltiplos serviços (Younes, Rizzotto e Araújo, 2017). Frequentemente, o IT revela-se fragmentado e marcado por lacunas na coordenação do cuidado, especialmente em situações de doenças crônicas (Savassi e colaboradores, 2022). Interrupções e descontinuidades nas transições entre serviços são comuns, evidenciando a realidade da fragmentação. Estudos

realizados no Brasil sobre o IT de pessoas com obesidade em diferentes contextos apontam trajetórias prolongadas, peregrinação entre serviços, demora no acesso à atenção especializada e experiências de desresponsabilização das equipes da APS (Silva e colaboradores, 2022).

Essa perspectiva é particularmente relevante na análise do cuidado à obesidade, cujo manejo pode culminar na indicação de cirurgia bariátrica. Trata-se de uma intervenção de alta complexidade, que requer acompanhamento multiprofissional na APS por pelo menos dois anos, exigindo coordenação efetiva entre os diversos níveis do SUS, conforme preconizam as linhas de cuidado e as diretrizes nacionais (Andrade e colaboradores, 2023).

Nessa interseção entre a necessidade de cuidado integrado e a realidade fragmentada do sistema emerge a questão central deste estudo: como se constitui o IT de indivíduos encaminhados para cirurgia bariátrica em um hospital universitário do Oeste do Paraná, considerando os diferentes níveis de atenção e os desafios encontrados ao longo desse processo? O objetivo foi analisar as características do IT de indivíduos com indicação para cirurgia bariátrica, identificando barreiras e facilitadores no acesso e na continuidade do cuidado nos diferentes níveis de atenção à saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS

Delineamento do Estudo

Trata-se de um estudo de métodos mistos, de desenho convergente e corte transversal, no qual dados quantitativos e qualitativos foram coletados e analisados de forma concomitante, sendo posteriormente integrados na etapa interpretativa. O

objeto comum da investigação foi o Itinerário Terapêutico (IT) de indivíduos com obesidade atendidos em um serviço especializado.

A análise quantitativa teve como finalidade caracterizar o perfil epidemiológico da amostra e identificar fatores associados à obesidade. Já os dados qualitativos foram examinados por meio da Análise de Conteúdo, conforme a proposta de Bardin, possibilitando a apreensão sistemática e objetiva dos sentidos atribuídos pelos participantes às suas experiências no percurso pelo sistema de saúde (Bardin, 2016 *apud* Valle; Ferreira, 2025).

No componente qualitativo, seguiram-se as três etapas clássicas da Análise de Conteúdo: Pré-análise: leitura flutuante e organização do material empírico; Exploração do material: codificação e categorização dos núcleos de sentido relacionados ao IT; Tratamento dos resultados: inferência e interpretação, etapa na qual as categorias foram analisadas à luz do referencial teórico do itinerário terapêutico.

Local, Período e Amostra

O estudo foi conduzido no Serviço de Obesidade e Cirurgia Bariátrica (SOCB) de um hospital universitário localizado no Oeste do Paraná, Brasil. A coleta de dados quantitativos, obtidos a partir de planilhas de acompanhamento, ocorreu entre setembro de 2024 e agosto de 2025. As entrevistas qualitativas foram realizadas nos meses de maio, junho e julho de 2025.

A amostra foi composta por 19 indivíduos adultos (idade ≥ 18 anos), em acompanhamento clínico multiprofissional no SOCB, na modalidade de atendimento coletivo. Os critérios de inclusão foram: participação em grupo de tratamento clínico iniciado em setembro de 2024; preenchimento completo do questionário de anamnese; e concordância em participar da entrevista. Foram excluídos indivíduos

com mais de três faltas ou com dados de anamnese incompletos. A amostra qualitativa foi intencional, recrutada a partir dessa coorte, com encerramento da inclusão determinado pela saturação teórica dos temas investigados.

Considerando o tamanho reduzido da amostra, as análises quantitativas tiveram caráter predominantemente descritivo e exploratório. Os modelos de regressão logística foram empregados de forma restrita, com interpretação dos intervalos de confiança e sem pretensão de generalização dos resultados para outras populações. Para alcançar o objetivo de analisar o IT, adotou-se uma estratégia integrada de coleta e análise de dados, descrita a seguir.

Coleta de dados para caracterização do itinerário terapêutico e do perfil sociodemográfico. Os dados quantitativos foram extraídos dos prontuários do SOCB, contemplando variáveis relacionadas ao percurso assistencial (tempo desde a primeira busca por cuidado, número de serviços previamente acessados e ponto de entrada no SUS), além de variáveis sociodemográficas e clínicas (sexo, idade, escolaridade, índice de massa corporal). Para os dados qualitativos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, guiadas por um roteiro centrado na experiência do IT. O roteiro explorou: a história e a motivação da busca por cuidado; a trajetória e as transições entre os serviços de saúde; a relação com os profissionais de saúde; as percepções sobre barreiras e facilitadores ao longo do percurso; a experiência no SOCB. As entrevistas tiveram duração média de 40 minutos, foram gravadas em áudio, transcritas integralmente e devolvidas aos participantes para validação de conteúdo.

Análise dos dados

Na abordagem quantitativa, os dados sociodemográficos, antropométricos e de comorbidades foram extraídos das planilhas de acompanhamento mensal do SOCB.

A análise estatística foi realizada no *software* R (versão 4.3.2), utilizando o pacote *tidyverse* para organização dos dados e funções do pacote *stats* para a construção de modelos de regressão logística binária. Esses modelos foram empregados de forma exploratória para estimar razões de chances (*odds ratio*, OR) entre obesidade e variáveis sociodemográficas selecionadas, com intervalo de confiança de 95%. A seleção de variáveis considerou a plausibilidade teórica e a limitação imposta pelo pequeno número de observações.

A análise qualitativa seguiu as etapas da Análise de Conteúdo descritas anteriormente e utilizou os *softwares* RQDA e TAMS *Analyzer* para codificação e recuperação de trechos, permitindo a construção das categorias temáticas. Os resultados quantitativos, como o tempo médio do IT, e os qualitativos, como os relatos sobre barreiras que contribuíram para esse tempo, foram sistematicamente contrastados e integrados, com o objetivo de construir uma compreensão multidimensional e conferir maior validade ao objeto de estudo.

Aspectos Éticos

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), sob o parecer nº 7.199.464. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para assegurar o anonimato e a confidencialidade, os dados foram codificados (P1, P2, ...), os áudios foram destruídos após a transcrição e os arquivos eletrônicos foram armazenados em computador protegido por senha, com acesso restrito aos pesquisadores. Os riscos de constrangimento foram minimizados pelo anonimato e pela condução das entrevistas em caráter não julgador.

RESULTADOS

Perfil Sociodemográfico e Fatores Associados à Obesidade na Amostra

A amostra foi composta predominantemente por mulheres (78,4%), com média de idade de 42,3 anos ($\pm 10,1$). Identificaram-se associações significativas entre obesidade e determinantes sociais específicos, conforme demonstrado nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Prevalência de obesidade por sexo, faixa etária e escolaridade, n=19 (2024).

Categoria	n	Prevalência (%)	p-valor
Mulheres	14	78,4	0.039
Homens	5	21,6	
18–29 anos	6	28,9	0,902
30–49 anos	7	37,4	
50+ anos	6	33,7	
Ensino fundamental	7	37,7	0,870
Ensino médio	7	34,4	
Ensino superior	5	27,9	

Fonte: Elaboração própria com dados do SOCB.

A escolaridade e a faixa etária não se mostraram relevantes ($p < 0,05$) nesta análise. Contudo, a regressão logística identificou a baixa escolaridade como fator de risco quando vista de forma independente para obesidade (OR = 1,52; IC 95%: 1,33–1,72). A natureza do trabalho teve relação significativa com o desfecho. Trabalhos sedentários, como atividades em *home office* ou em escritório, aumentaram em 1,4 vezes a chance de obesidade (OR = 1,40; IC 95%: 1,18–1,65), enquanto ocupações fisicamente intensas exerceram efeito protetor (OR = 0,72; IC 95%: 0,60–0,87).

Tabela 2 – Associação entre fatores sociodemográficos e obesidade (modelos de regressão logística).

Fator	OR	IC 95 %
--------------	-----------	----------------

Trabalho sedentário (<i>home office</i> /escritório)	1,40	1,18–1,65
Baixa escolaridade (ensino fundamental)	1,52	1,33–1,72
Ocupação fisicamente intensa (agricultura, construção)	0,72	0,60–0,87
Sexo feminino	1,12	0,98–1,28
Idade > 30 anos	1,25	1,10–1,42

Fonte: Elaboração própria com base em dados do SOCB (2024).

Caracterização do Itinerário Terapêutico: Tempo, Trajetória e Acesso

A análise do IT evidenciou uma trajetória assistencial prolongada e marcada pela fragmentação. O tempo médio entre a primeira busca por cuidado relacionado à obesidade e o ingresso no SOCB foi de 5,8 anos, variando de um mês a dez anos, o que demonstra significativa heterogeneidade nas experiências. Ao longo desse percurso, os participantes consultaram, em média, 3,2 serviços ou profissionais antes de serem encaminhados ao atendimento especializado.

Em 73,7% dos casos, a APS não desempenhou o papel de ordenadora efetiva do cuidado, resultando em encaminhamentos inconclusivos, demora excessiva e necessidade de recorrer ao setor privado para acesso à atenção especializada. Apenas 21% dos participantes estavam em acompanhamento contínuo há mais de dois anos, o que sugere que, para a maioria, o tempo de cuidado estruturado e multiprofissional nesse nível da rede foi inferior ao período recomendado para o tratamento clínico, conforme diretrizes nacionais (Andrade e colaboradores, 2023). Esse achado indica um itinerário prévio caracterizado pela descontinuidade do cuidado.

As comorbidades mais frequentes, relatadas como motivadoras da busca por atendimento, foram hipertensão arterial sistêmica (45,2%), ansiedade (38,7%) e dislipidemia (29%).

A Experiência Qualitativa do IT: Barreiras, Navegação e o Papel do SOCB

A análise qualitativa permitiu sistematizar as barreiras enfrentadas ao longo do IT, caracterizado pela longa duração. As categorias temáticas estão apresentadas no Quadro 3. As narrativas evidenciaram a fragmentação do cuidado como experiência recorrente, vivida pelos participantes em diferentes momentos da trajetória assistencial.

Quadro 3 – Categorias temáticas da experiência no Itinerário Terapêutico.

Categoria Temática	Foco Principal	Exemplo de Fala
Fragilidades no acesso e Coordenação	Demoras, burocracia, despreparo da APS e falta de integração.	<i>“O posto não sabia como lidar com a nossa papelada”</i> (P16)
Enfrentamento do Estigma	Experiência de culpabilização e humilhação por profissionais de saúde.	<i>“O médico me mandou olhar no espelho”</i> (P19)
Determinantes Sociais do IT	Impacto da renda, escolaridade e ambiente no acesso a cuidado e alimentos saudáveis.	<i>“É mais barato comprar linguiça e macarrão do que frutas e peixe”</i> (P15)
A Rede de Apoio e o Cuidado Multiprofissional	Importância do grupo (SOCB) e da família como facilitadores do percurso.	<i>“No grupo multidisciplinar não nos sentimos sozinhas na caminhada”</i> (P17)

Fonte: Entrevistas com os participantes (2025).

Pontos de Ruptura: A APS entre a Porta de Entrada e a Barreira

Embora a APS se configure como a principal porta de entrada para o tratamento da obesidade, sua atuação como instância coordenadora do cuidado mostrou-se pouco frequente. Os relatos dos participantes evidenciaram despreparo sistêmico no manejo da condição, marcado por fragilidades relacionadas à orientação clínica e aos fluxos de encaminhamento na rede. As falas ilustram essas dificuldades: *“As funcionárias estavam totalmente despreparadas; não sabiam encaminhar a documentação”* (P18). *“Demorei três meses para conseguir vaga com endocrinologista e, nesse tempo fiquei sem nenhuma orientação”* (P1).

O Peso do Estigma do Percurso

O estigma configurou-se como uma barreira central no IT, manifestando-se tanto nas práticas institucionais quanto na dimensão subjetiva das trajetórias dos participantes. Os atendimentos foram frequentemente permeados por discursos moralizantes e culpabilizantes de profissionais de saúde, associados a sentimentos de humilhação e, em alguns casos, à intenção de abandono do cuidado.

A fala a seguir ilustra essa experiência: *“Um endocrinologista disse que até os cachorros da minha casa deveriam fazer dieta. Pensei em desistir de tudo”* (P16). Os relatos evidenciam que o estigma não apenas dificultou o acesso e a adesão às terapias, mas também produziu efeitos emocionais negativos que fragilizaram a continuidade do cuidado. Essa vivência contrastou com a experiência descrita no SOCB, onde os participantes relataram maior acolhimento e suporte multiprofissional.

O SOCB como Organizador do IT e Espaço de Acolhimento

O estigma emergiu como um elemento central de bloqueio no IT, expressando-se tanto nas práticas institucionais quanto na experiência subjetiva dos participantes. Relatos de atendimentos permeados por discursos culpabilizantes por parte de profissionais de saúde foram associados a sentimentos de humilhação e em alguns casos, à intenção de abandonar o cuidado. Em contraste, no serviço especializado, os participantes relataram: *“Aqui aprendi que a obesidade é uma doença, não é falta de força de vontade. Isso tirou um peso”* (P15).

DISCUSSÃO

Neste estudo, evidenciou-se que o IT de indivíduos com obesidade na região Oeste do Paraná caracteriza-se por uma jornada longa, fragmentada e condicionada

por determinantes sociais (Lopes e colaboradores, 2023). A análise integrada das informações quantitativas e qualitativas permitiu compreender que a elevada prevalência da obesidade, longe de se restringir a uma especificidade clínica, está diretamente relacionada à forma como o sistema de saúde se organiza e às desigualdades sociais que moldam o acesso e a continuidade do cuidado (Malta e colaboradores, 2021).

O tempo médio de 5,8 anos até o ingresso no serviço especializado, a circulação por múltiplos pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e os relatos recorrentes de descoordenação do cuidado traduzem, no plano empírico, críticas já consolidadas na literatura sobre a fragmentação da atenção no SUS (Giovanella e Mendes, 2020). As trajetórias dos participantes revelam, na prática, os “pontos de ruptura” conceituados por Trad e Castellanos (2018), sobretudo na transição entre a APS e a atenção especializada, convergindo com os achados de Silva e colaboradores (2022) acerca das dificuldades nos processos de regulação e nos fluxos de referência relativos ao manejo da obesidade.

Ainda que a APS seja normativamente concebida como instância ordenadora e coordenadora do cuidado (Brasil, 2020; Brasil, 2025), no presente estudo ela operou predominantemente como uma barreira burocrática, seja pelo despreparo das equipes, seja pela fragilidade dos fluxos de referência e contrarreferência. Esse achado é especialmente relevante, pois indica que a principal porta de entrada do sistema converte-se, paradoxalmente, em um obstáculo ao cuidado integral de uma condição crônica. Tal cenário contrasta com as diretrizes da *Secretaria de Estado da Saúde do Paraná* (2022), que reforçam o papel da APS como coordenadora do cuidado e preveem fluxos assistenciais integrados para reduzir rupturas.

Um resultado central e paradoxal refere-se ao papel assumido pelo SOCB, um

serviço de alta complexidade, que passou a exercer a função de coordenação do IT, função que deveria ser desempenhada prioritariamente pela APS, fenômeno também descrito em outros estudos sobre obesidade grave em serviços especializados (Silva e colaboradores, 2022). A discrepância entre prática e norma torna-se evidente quando comparada às recomendações da Linha de Cuidado do Paraná (2022), que prevê a articulação entre APS, atenção especializada e hospitalar, evitando que serviços de alta complexidade assumam funções de coordenação.

Na percepção dos usuários, foi apenas nesse espaço que se estruturou um projeto terapêutico integrado, acolhedor e contínuo, aproximando-se das descrições de projetos terapêuticos singulares como dispositivos de superação da fragmentação do cuidado (Pasche e colaboradores, 2022). Esse cenário aponta para uma alteração estrutural na organização da RAS, uma vez que a assistência destinada aos casos mais complexos assume a função de suprir fragilidades relacionadas à longitudinalidade, à integralidade e à coordenação do cuidado.

O sucesso do modelo multiprofissional do SOCB, ao promover a integração do cuidado e o enfrentamento do estigma, evidencia, simultaneamente, sua efetividade enquanto dispositivo assistencial e a falha sistêmica que torna sua existência necessária.

Na análise qualitativa, foi possível aprofundar a compreensão do papel do estigma ao longo do IT, evidenciando que ele não se restringe a um aspecto relacional pontual, mas atua como uma barreira estruturante ao acesso e à continuidade do cuidado (Leão e Lussi, 2021). Experiências de humilhação e culpabilização por parte de profissionais de saúde, especialmente no âmbito da APS, foram relatadas como eventos marcantes, capazes de provocar sofrimento, desmotivação e, em alguns casos, a desistência do tratamento. Esses episódios contribuíram para o

prolongamento do IT, achado consistente com revisões sobre estigma de peso em serviços de saúde no Brasil (Ferraz e colaboradores, 2020; Bertolini, Branco e Amorim, 2022).

Os dados dialogam com a literatura que compreende o estigma como determinante social da saúde, operando na micropolítica das interações e produzindo iniquidades (Souza-Munoz e colaboradores, 2020). Em contraste, a superação do estigma no ambiente do SOCB foi descrita pelos participantes como uma experiência libertadora e decisiva para a adesão ao cuidado. Esse resultado reforça a importância da qualificação da comunicação e da humanização do atendimento como componentes centrais da efetividade da linha de cuidado, conforme defendido por estudos que propõem abordagens centradas na pessoa com obesidade (Rodrigues e Rodrigues, 2023). Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (2022) também reconhece o estigma como barreira ao cuidado e recomenda práticas de acolhimento e comunicação não culpabilizante, reforçando a necessidade de alinhamento entre diretrizes e prática cotidiana.

A associação quantitativa entre piores desfechos, como maior tempo de IT e menor acesso a serviços especializados, fatores como baixa escolaridade e ocupações sedentárias foi também narrada qualitativamente como uma realidade concreta de escassez de recursos materiais, simbólicos e temporais (Malta e colaboradores, 2021; Santos, Silva e Gomes, 2025).

Considerando que todos os participantes deste estudo são usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e que não há comparação com outros arranjos assistenciais, os resultados devem ser interpretados no contexto das dinâmicas estruturais e organizacionais da própria rede pública. Esse achado está em consonância com análises recentes sobre desigualdades regionais no cuidado à obesidade no Brasil

(Costa, 2020; Lopes e colaboradores, 2021).

Os resultados evidenciam, portanto, que o IT não constitui um percurso neutro, mas um processo socialmente construído que reflete e reproduz desigualdades sociais pré-existentes, conforme estudos que associam o excesso de peso a determinantes como renda, escolaridade, gênero e território (Lima e colaboradores, 2025). Tal interpretação converge com a literatura dos determinantes sociais da saúde ao indicar que as iniquidades não decorrem apenas de fatores individuais, mas estão ancoradas na distribuição desigual de poder, recursos e oportunidades ao longo da vida (Brasil, 2023; Lopes e colaboradores, 2023).

Essas evidências reforçam a necessidade de políticas públicas que superem a universalidade formal, incorporando estratégias equitativas e ações afirmativas voltadas a grupos socialmente vulnerabilizados (Brasil, 2023).

Os resultados apontam para a necessidade de reestruturação da linha de cuidado à obesidade, orientada pela lógica do IT vivenciado pelos usuários da região oeste do Paraná, em consonância com as recomendações de linhas de cuidado nacionais e estaduais (Santa Catarina, 2017; Minas Gerais, 2025; Paraná, 2022).

No que se refere às limitações, destacam-se o desenho transversal, que apreende o IT em um recorte temporal específico, e a realização da pesquisa em um único serviço especializado, o que pode restringir a generalização dos resultados. Nesse sentido, estudos longitudinais que acompanhem o IT no período pós-cirúrgico, bem como investigações que avaliem a implementação e os efeitos de protocolos de integração entre a APS e a atenção especializada, mostram-se necessários. Ainda assim, os resultados apresentados oferecem uma contribuição relevante para o planejamento e o aprimoramento de políticas públicas de saúde, ao evidenciar, de forma integrada, como a organização dos serviços e os determinantes sociais moldam

o cuidado à obesidade, apontando caminhos para estratégias mais efetivas e equitativas.

CONCLUSÃO

Este estudo analisou o Itinerário Terapêutico (IT) de indivíduos com obesidade atendidos em um serviço especializado no Oeste do Paraná e respondeu ao objetivo proposto ao identificar barreiras e facilitadores no acesso e na continuidade do cuidado nos diferentes níveis da Rede de Atenção à Saúde.

Os resultados evidenciaram três elementos centrais: (1) uma trajetória assistencial prolongada, com média de 5,8 anos até o acesso ao serviço especializado, marcada por rupturas na transição entre a Atenção Primária e a atenção especializada; (2) o papel paradoxal da atenção terciária, na qual o serviço de alta complexidade assumiu funções de coordenação do cuidado, suprimindo fragilidades da APS; e (3) a influência dos determinantes sociais, como baixa escolaridade, ocupações precárias e estigma de profissionais da APS, que atuaram como barreiras estruturais, ampliando desigualdades no acesso e na continuidade do cuidado.

Esses achados reforçam a relevância do IT como ferramenta analítica para compreender falhas na integração da Rede de Atenção à Saúde e demonstram que o estigma não se limita a uma dimensão simbólica, mas opera como mecanismo concreto de exclusão. A análise aponta para a necessidade de reestruturação da linha de cuidado à obesidade, em consonância com diretrizes nacionais e estaduais, fortalecendo a APS, promovendo fluxos assistenciais integrados e incorporando estratégias equitativas e humanizadas.

REFERÊNCIAS

- Andrade, R.S.; Cesse, E. Â.P.; Figueiró, A.C. Cirurgia bariátrica: complexidades e caminhos para a atenção da obesidade no SUS. *Saúde em Debate*. Rio de Janeiro. Vol. 47. Num. 138. 2023. p. 641-657.
- Bertolini, M.; Branco, L.; Amorim, L. O estigma da obesidade dentro do atendimento à saúde e seu impacto na adesão ao tratamento. *Revista Saúde e Desenvolvimento*. Curitiba. Vol. 14. Num. 2. 2022. p. 1-15.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Instrutivo de abordagem individual para o manejo da obesidade no SUS*. Brasília. 2020.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Relatório Público de Estado Nutricional. Macroregião oeste (PR), adultos*. Brasília. 2025.
- Brasil. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. *Obesidade como questão social e interseccional*. Brasília. 2023.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Linha de cuidado à pessoa adulta com sobrepeso e obesidade*. Belo Horizonte. SES-MG. 2025.
- Costa, C.S.; et al. Obesidade no Brasil: desafios sociais, econômicos e de atenção à saúde. *Revista Acervo Saúde*. Rio de Janeiro. Vol. 12. Num. 11. 2020. p. 1-10.
- Ferraz, L.R.; et al. Estigmas dos profissionais de saúde frente ao paciente obeso: uma revisão integrativa. *Revista Sustinere*. Rio de Janeiro. Vol. 8. Num. 2. 2020. p. 300-320.
- Giovanella, L.; Mendes, A. Organização das redes de atenção à saúde no SUS. IN Giovanella, L.; et al. (org.). *Políticas e sistema de saúde no Brasil*. 3. ed. Rio de Janeiro. Fiocruz. 2020.
- Hosmer, D.W.; Lemeshow, S.; Sturdivant, R. *Applied Logistic Regression*. 3. ed. New York. Wiley. 2013.
- Huang, R. RQDA: Qualitative Data Analysis. Pacote do sistema R para análise qualitativa.
- Leão, A.; Lussi, I.A.O. Estigmatização: consequências e possibilidades de enfrentamento em centros de convivência e cooperativas. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*. Botucatu. Vol. 5. 2021.
- Lima, M.G.; et al. Análise de iniquidades entre determinantes demográficos e sociais associados ao sobrepeso e obesidade. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. São Paulo. Vol. 28. 2025. e250038.
- Lopes, A.P.; et al. Obesidade no Brasil: desafios sociais, econômicos e de saúde

pública. *Revista Acervo Saúde*. Rio de Janeiro. Vol. 16. Num. 1. 2023. p. 1-12.

Lopes, M.S.; et al. O manejo da obesidade na Atenção Primária à Saúde no Brasil é adequado? *Cadernos de Saúde Pública*. Rio de Janeiro. Vol. 37. 2021.

Malta, D.C.; et al. Associação de desigualdades sociais com excesso de peso e obesidade em adultos brasileiros. *Revista de Saúde Pública*. São Paulo. Vol. 55. 2021.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde. *Linha de cuidado à pessoa adulta com sobrepeso e obesidade*. Belo Horizonte. 2025.

Pasche, D.F.; et al. Itinerário terapêutico e construção de um projeto terapêutico singular em rede para um caso raro de síndrome genética. *Revista Paranaense de Enfermagem*. Curitiba. Vol. 6. Num. 1. 2022. p. 1-15.

R Core Team. *R: A language and environment for statistical computing*. Version 4.4. Vienna. R Foundation for Statistical Computing. 2024.

Rodrigues, F.O.; Rodrigues, F.A.A. Atuação multidisciplinar e humanização nos atendimentos de cirurgia bariátrica. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*. Vol. 15. Num. 9. 2023. p. 9961-9970.

Santa Catarina. Secretaria de Estado da Saúde. *Linha de cuidado para atenção à saúde das pessoas com sobrepeso e obesidade*. Florianópolis. 2017.

Santos, L.; Silva, A.; Gomes, R. Determinantes sociais da obesidade no Brasil: uma abordagem interseccional. *Revista de Saúde Coletiva*. São Paulo. Vol. 35. 2025. e220015.

Savassi, L.C.M.; et al. *Tratado de Atenção Domiciliar*. Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade – SBMFC. São Paulo. Manole. 2022. p. 161-162.

Sousa-Munoz, R.L.; et al. Estigma, obesidade e saúde: interfaces com os determinantes sociais. *Revista de Nutrição*. Campinas. Vol. 33. 2020. e190130.

TAMS Analyzer. *TAMS Analyzer: Software para análise qualitativa*. Disponível em: <<https://tamsys.sourceforge.io/>>. Acesso em: 05 jul. 2025.

Trad, L.A.B.; Castellanos, M.E.P. A jornada do paciente: mapeamento e análise do itinerário terapêutico de usuários do SUS. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*. Botucatu. Vol. 22. Num. 64. 2018. p. 257-270.

Valle, Paulo R. D; Ferreira, Jacques de L. Análise de Conteúdo na Perspectiva de Bardin: contribuições e limitações para pesquisa qualitativa em educação. *Rev. Educação em Revista*. Belo Horizonte, v. 41, 2025. DOI: 10.1590/0102-469849377.

World Obesity Federation. *World Obesity Atlas 2025*. London. World Obesity Federation. 2025.

Younes, S.; Rizzotto, M.L.F.; Araújo, A.C.F. Itinerário terapêutico de pacientes com obesidade atendidos em serviço de alta complexidade de um hospital universitário. *Saúde em Debate*. Rio de Janeiro. Vol. 41. Num. 115. 2017. p. 1046-1060.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do itinerário terapêutico de indivíduos encaminhados para cirurgia bariátrica em um hospital de ensino revelou aspectos fundamentais sobre a trajetória de cuidado percorrida por essa população no Sistema Único de Saúde. Os achados deste estudo evidenciam a complexidade multidimensional da obesidade grave e os desafios enfrentados pelos usuários na busca por tratamento.

Neste contexto, independente das mudanças necessárias na RAS, existem fatores comportamentais que podem ser implementados em nível individual e coletivo. Trata-se de pequenos ajustes comportamentais que podem contribuir, em certo grau, com a melhoria da qualidade de vida e efetividade do tratamento para obesidade. Podemos destacar:

- Valorização da cultura alimentar local com adaptações saudáveis, envolvendo *chefs*, nutricionistas e comunidades para reinventar pratos tradicionais;
- Articulação entre sustentabilidade e saúde, incentivando o consumo de produtos locais, a agricultura urbana e o transporte ativo;
- Integração do manejo de comorbidades nos programas de obesidade.

Considerando que muitos participantes convivem com hipertensão, diabetes, doenças renais e problemas articulares, recomenda-se que o tratamento inclua monitoramento clínico regular, acesso a medicamentos, fisioterapia e orientações específicas para exercícios seguros.

As limitações decorrem do uso de dados do SISVAN, que não abrangem a totalidade da população; do número relativamente pequeno de entrevistas; e da impossibilidade de inferir causalidade com base em dados observacionais. Estudos futuros podem ampliar a amostra, incluir adolescentes e idosos, e investigar como políticas específicas impactam a obesidade em curto e longo prazo. Pesquisas que explorem a influência de raça e etnia na obesidade regional são necessárias para aprofundar o debate sobre equidade.

A obesidade continua a ser um desafio de saúde pública no Oeste do Paraná, exigindo respostas coordenadas e contextualizadas. Este estudo, realizado em 2025, mostra que o período recente abre oportunidades para remodelar programas de saúde e implementar ações inovadoras. A humanidade dos relatos colhidos reforça que soluções precisam ser construídas com a participação das comunidades,

considerando seus saberes, desafios e aspirações. Somente assim será possível avançar rumo a uma sociedade mais saudável, justa e sustentável.

A análise do Itinerário Terapêutico (IT) de indivíduos encaminhados para cirurgia bariátrica em um hospital universitário do Oeste do Paraná evidenciou que o cuidado em obesidade permanece condicionado por barreiras estruturais e simbólicas que configuram um percurso fragmentado e desigual. A trajetória assistencial dos usuários revela-se socialmente construída e marcada pela descontinuidade do cuidado, pelo estigma e pelas iniquidades no acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os resultados deste estudo reforçam que o tempo médio prolongado até o acesso ao serviço especializado reflete falhas na coordenação entre os diferentes níveis de atenção, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), que deveria desempenhar o papel de ordenadora do cuidado. O deslocamento dessa função para o serviço de alta complexidade indica a persistência da fragmentação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e a necessidade de reorganização da linha de cuidado à obesidade, pautada pelos princípios da integralidade, longitudinalidade e equidade.

A influência dos determinantes sociais — como escolaridade, ocupação e renda — manifesta-se não apenas nas condições de vida, mas também nas oportunidades de cuidado e na forma como os indivíduos são coletados no sistema. O estigma aparece como elemento transversal, comprometendo vínculos terapêuticos e contribuindo para trajetórias de exclusão. Tais evidências reforçam a urgência de estratégias de sensibilização, educação permanente e comunicação não culpabilizante nos serviços de saúde.

Diante desse cenário, destaca-se a importância de fortalecer a APS como núcleo de coordenação do cuidado, por meio de fluxos assistenciais integrados e práticas que consideram a singularidade das trajetórias dos usuários. Pequenas intervenções comportamentais e socioculturais — como o incentivo à valorização da cultura alimentar local, à sustentabilidade, ao transporte ativo e à integração do manejo multiprofissional das comorbidades — podem favorecer a adesão e a efetividade terapêutica.

Os resultados também indicam a necessidade de políticas públicas mais equitativas e territorializadas, capazes de enfrentar tanto os determinantes sociais da obesidade quanto as formas de estigmatização que atravessam o cuidado. Reforça-se, assim, que o enfrentamento da obesidade no SUS deve ser compreendido para

além da dimensão biomédica, como um processo ético, social e intersubjetivo que exige sensibilização profissional e responsabilização institucional.

Considerando as limitações do estudo — especialmente a amostra reduzida e o recorte transversal —, recomenda-se a realização de pesquisas longitudinais que acompanhem a TI em diferentes etapas do tratamento, inclusive no período pós-cirúrgico, além de estudos que examinam os impactos das políticas públicas na redução das desigualdades regionais.

Conclui-se que a construção de uma linha de cuidado eficaz à obesidade requer integração real entre os níveis de atenção, empatia nas relações de cuidado e políticas sustentadas pela perspectiva da equidade. Somente mediante o enfrentamento conjunto da fragmentação, o estigma e as desigualdades serão possíveis avançar rumo a um SUS mais justo, inclusivo e capaz de responder às complexas demandas da obesidade na contemporaneidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASSIS, M. A. A. et al. Impacto de um programa de intervenção nutricional no peso e na qualidade da dieta de mulheres adultas. *Revista de Nutrição*, v. 32, e180138, 2019.
- BARBOSA, Maria I. De C; SOLLÉRO, Laura; RECINE, Elizabetta. A Integralidade no Cuidado da Obesidade Infantil em Municípios Brasileiros. *Rev. Saúde Pública*. 58:33. (2024). Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2024058005632>>. Acesso em: 24 de janeiro de 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Promoção à Saúde. Manual de Atenção às Pessoas Com Sobrepeso e Obesidade no Âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde. Brasília: 2022.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Brasília: 2021. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2018: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
- COSTA, Mayara de Almeida; FONTES, Sarah Correia; RODRIGUES, Gabriela M. de Molina. Predisposição Genética Como Fator Determinante Para Ocorrência de Obesidade Infantil. *Rev. Liberum Accessum*. Set; 5(1). P. 32-41. (2020). Disponível em: <<https://revista.liberumaccesum.com.br/index.php/RLA/article/view/59/58>>. Acesso em: 29 de janeiro de 2026.
- FRANÇA, S. V. de; e PEREIRA, A. C. E. de S.; Itinerários Terapêuticos de Pessoas Hospitalizadas por Covid-19 no SUS: um estudo qualiquantitativo no Distrito Federal. *Rev. Saúde Debate*. v. 48 (141). Abr-Jun. 2024. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/STxc4dxKWHvNdjV4sVJ7V7J/?lang=pt>>. Acesso em: 21 jun. 2025.
- HOSMER, D. W.; LEMESHOW, S.; STURDIVANT, R. Regressão Logística Aplicada (Applied Logistic Regression). 3. ed. New York: Wiley, 2013.
- LEE, S. Y. et al. Advanced body composition assessment: from body mass index to body composition profiling. *Journal of Investigative Medicine*, v. 66, n. 5, p. 1-9, 2018.

- LORDANI, C. F. L. Representações sociais de sujeitos em situação de obesidade considerada grave: Trajetórias de vida e Itinerários terapêuticos no Sistema Único de Saúde (SUS). Originalmente apresentada como tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos — UNISINOS. São Leopoldo: 2019.
- MANCINI, M. C. et al. Abordagem multidisciplinar no tratamento da obesidade: experiência de um hospital universitário brasileiro. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*, v. 61, n. 5, p. 414-420, 2017.
- MEDINA, Rebeca C. M. Sad., et al. Cirurgia Bariátrica: impactos metabólicos e complicações gastrointestinais. *Rev. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*. Vol. 7. P. 3017-3023. (2025) Disponível em: <<https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n1p3017-3023>>. Acesso em: 29 de janeiro de 2026.
- MENDES, Verônica C. C; et al. O Papel da Equipe Multidisciplinar no Manejo da Obesidade na Atenção Primária à Saúde. *Rev. Journal of Social Issues and Health Sciences*. Terezina, vol. 2. N° 2. P. 1-15. (2025). Disponível em: <<https://ojs.thesiseditora.com.br/index.php/jsihs/article/view/302/266>>. Acesso em: 24 de janeiro de 2026.
- PALMEIRA, A. L. et al. Change in body image and psychological well-being during behavioral obesity treatment: Associations with weight loss and maintenance. *Body Image*, v. 23, p. 46-53, 2017.
- PARANÁ. Ministério Público do Paraná – MPPR. Macrorregionais de Saúde do Paraná. Disponível em: < https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/rs/1_macrorregionais.htm>. Acesso em: 17 jul. 2023.
- PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Divisão de Promoção da Alimentação Saudável e Atividade Física. Linha de Cuidado às Pessoas com Sobrepeso e Obesidade: adulto. Curitiba: 2022. Disponível em: < https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-06/linha_de_cuidado_sobrepeso_e_obesidade_diagramada_final.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2023.
- PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Resolução nº 225/2020 de 03 de março de 2020. Disponível em: < https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/225_20.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2023.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Divisão de Atenção à Saúde da Mulher. Linha de cuidado Materno Infantil do Paraná. Vol. 8º Ed. Curitiba: 2022. Disponível em: <www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-03/linha_guia_mi_gestacao_8a_ed_em_28.03.22.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2024.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Superintendência de Atenção à Saúde. Linha Guia de Diabetes Mellitus. Curitiba: 2018a. Disponível em: <www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@4ee68bf2-3e1e-45ec-ac63-1aa54abce73c&emPg=true>. Acesso em: 30 jan. 2024.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Superintendência de Atenção à Saúde. Linha Guia de Hipertensão Arterial. Curitiba: 2018b. Disponível em: <www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@38dab7e2-7a49-410e-aea4-de87d76ece09&emPg=true>. Acesso em: 30 jan. 2024.

PEREIRA, Maria L. F; COSTA FILHO, Leonço A. A Aceitação do Tratamento Psicológico dos Homens no Combate à Obesidade. Rev. Matogrossense de Saúde. (2024). Disponível em: <<https://revistas.fasipe.com.br/index.php/REMAS/article/view/305/273>> 2024>. Acesso em: 25 de janeiro de 2026.

R Core Team (2024). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).

RIBEIRO, Ana C. L., et al. Relação Entre Consumo de Ultraprocessados e o Aumento da Prevalência da Obesidade. Rev. Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento – RBONE. Vol. 19. N° 123. P. 1249-1259. Nov-Dez. (2025). Disponível em: <<https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/2967>>. Acesso em: 29 de janeiro de 2026.

RQDA. Pacote do sistema R específico parra análise qualitativa. Disponível em: <<http://rqda.r-forge.r-project.org/>>.

SANTOS, Silvio S. S., et al. Atualizações na Cirurgia Bariátrica e Metabólica: indicações e resultados. Rev. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences. Vol. 7. P. 2562-2574. (2025) Disponível em:<<https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/5347/5293>>. Acesso em: 30 de janeiro de 2026.

- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ (SESA-PR). *Plano Estadual de Saúde 2024-2027*. Curitiba: SESA-PR, 2024. Documento oficial que estabelece a divisão do estado em 22 Regionais de Saúde. Disponível em: <<https://conselho.saude.pr.gov.br/Pagina/Plano-Estadual-de-Saude>>. Acesso em: 24 de janeiro de 2026.
- SILVA, Raíssa G. A., et al. Tratamento Medicamentoso e Estilo de Vida Para Obesidade: uma revisão integrativa. *Rev. Research Society and Development*, v. 14. N° 1. (2025) Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v14i1.47970>>. Acesso em: 30 de janeiro de 2026.
- SOUSA, Henrique Brio, et al. Correlação Entre Variáveis Antropométricas, Composição Corporal e Consumo Máximo de Oxigênio em Adolescentes com Excesso de Peso ou Obesidade. *Rev. Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento – RBONE*. (2024). São Paulo, v. 18, n° 114, p. 470-482. Mai-Jun, 2024. Disponível em: <<https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/2419/1449>>. Consulta em: 24 de janeiro de 2026.
- TAMS Analyzer. Disponível em: <https://tamsys.sourceforge.io/>.
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ. Plano de Desenvolvimento Institucional: PDI 2024-2028. Cascavel: Unioeste, 2024. Disponível em: https://www.unioeste.br/portal/arquivos/PDI_2024_2028.pdf. Acesso em: 15 jan. 2026.
- VALLE, Paurlo R. D; FERREIRA, Jacques de L. Análise de Conteúdo na Perspectiva de Bardin: contribuições e limitações para pesquisa qualitativa em educação. *Rev. Educação em Revista*. Belo Horizonte, v. 41, 2025. DOI: 10.1590/0102-469849377. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/edur/a/hhywJFvh7ysP5rGPn3QRFWf/?format=pdf&lang=pt>>. Conslta em: 22 de janeiro de 2026.
- WORLD OBESITY FEDERATION (WOF). *World Obesity Atlas 2025*. London: World Obesity Federation, 2025. Disponível em:< [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://data.worldobesity.org/publications/World d-obesity-atlas-2025-v7.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://data.worldobesity.org/publications/World-d-obesity-atlas-2025-v7.pdf)>. Acesso em: 31 de Agosto de 2025.
- YOUNES, Soraia; RIZZOTTO, Maria Lúcia Frizon; ARAÚJO, Allan Cezar Faria,. Itinerário terapêutico de pacientes com obesidade atendidos em serviço de alta complexidade de um hospital universitário. *Revista Saúde Debate*. V. 41, N. 115, P. 1046-1060, OUT-DEZ 2017. Rio de Janeiro. Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/k4SfXFCLL4sbtZbZNZWmbNc/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 16 dez. 2023.

APÊNDICE 1**Instrumento de Coleta de Dados**

Nome: _____

Data de Nascimento: _____ / _____ / _____.

Cada um de nós percorreu um longo caminho até aqui. Alguns passaram por muitas consultas médicas, fizeram muitos exames e tomaram vários tipos de medicamentos. Hoje gostaríamos de saber um pouco mais sobre os eventos relacionados com o seu tratamento para obesidade. Poderia nos contar um pouco mais sobre você?

1 – Gostaria que nos contasse como você cuidava da sua saúde antes de procurar atendimento para obesidade no posto de saúde perto de sua casa.

2 – Nos conte se você conseguiu e como fez para melhorar sua saúde depois de procurar atendimento para obesidade no posto de saúde perto de sua casa.

3 – Se você foi encaminhado para algum médico especialista, nos conte como você conseguiu cuidar melhor da sua saúde depois que foi encaminhada(o).

4 – Depois que você foi encaminhada (o) para o Grupo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do HU, conseguiu cuidar melhor da sua saúde e do tratamento da obesidade? Como você faz?

5 – Você acredita que os atendimentos dos profissionais de saúde pelos quais passou até o momento lhe ajudaram a cuidar melhor da sua saúde e a controlar a obesidade?

ANEXO 1

Dados Gerais		
Nome do paciente:		
Nascimento: __/__/____	Idade:	Gênero: () Masculino () Feminino
Religião/Preferência religiosa:		
Unidade de Saúde de referência:		Município de origem:
Telefone 1 para contato:	() WhatsApp	Melhor horário para contato:
Telefone 2 para contato:	() WhatsApp	Melhor horário para contato:
Escolaridade:		Ocupação:
Estado civil: () casado () solteiro () união estável () outros _____		
Beneficiário de Programa Social: () N () S, se sim, qual(is)? _____		
Filhos () não () sim, () Nº de filhos, Idade: _____		
Idade dos outros membros da família e grau de parentesco: () _____ () _____ () _____		
Há outros membros da casa acima do peso: () não () sim.		
Se Sim, quem? _____ Renda mensal familiar: _____ Quantas pessoas moram em casa: _____		
História regressa:		
Você fez acompanhamento para perda de peso no SUS? () Sim () Não		
Por quanto tempo? _____ Em qual serviço? _____		
Antecedentes familiares para obesidade: () Sim () Não Quem? _____	A distribuição da obesidade no seu corpo se dá principalmente em que região? () geral () abdômen () quadril	
Há quanto tempo mantém este peso? _____ Tempo de Obesidade (em anos): _____		
O que você relaciona ao seu aumento de peso?		
Qual o tipo de tratamento foi realizado para obesidade? () Reeducação alimentar () Psicoterapia () Medicamento. Qual? _____ () Outros	Resultados obtidos: () Perda de peso, quanto? _____ () Mudou de comportamento () Melhorou a alimentação () Melhorou controle de outros problemas de saúde () Melhorou qualidade de vida () Sem alteração () outro:	
Estilo de Vida		

Etilismo: () N () S, se sim: Bebida: () cerveja () vinho () pinga () outro
 _____ **Frequência de consumo álcool:** () Diário
 () Semanal Quantidade: _____ **Tabagismo:** () N () S, se sim qual tipo:
 _____ Quantidade por dia: __ **Drogas:** () N () S, se sim
 qual tipo: _____ Frequência: _____
 _____ **Faz o uso de suplementos** (se sim, quais?):
 _____ Ingestão hídrica/dia:
 _____ **Tempo de mastigação** em uma refeição principal: () rápida (até 20 min) () normal
 (20-40 min) () devagar (mais de 40 min) **Ritmo intestinal:** frequência diária:
 _____ / frequência semanal: _____

Avaliação Física e Histórico de Obesidade	
Prática de Atividade Física: () N () S Tipo de Exercício: () Caminhada/Corrida () Ciclismo () Musculação () Outro Qual? Frequência de exercício: () Diária () 1 a 2 x/sem () 3 ou + x/sem Duração do exercício por semana: _____ Quantos minutos/sem: () < 150 () 150min Circunferência Pescoço: _____ cm Peso atual: _____ Kg Altura: _____ mIMC: _____ Kg /m ²	
Avaliação Odontológica	
Queixa Principal: _____ Faz ou está em tratamento odontológico? () Sim () Não A gengiva sangra com facilidade? () Sim () Não Com que frequência você escova os dentes? () 1 vez por dia () 2 vezes por dia () 3 vezes por dia () Mais de 3 vezes por dia.	
Avaliação do Estágio de Motivação de Mudança	
Você pretende perder peso nos próximo 6 meses? () Sim () Não Não Você pretende perder peso nos próximo 30 dias? () Sim () Não Não Você fez recentemente mudanças no seu estilo de vida para perder peso (mudança na alimentação, atividade física ou terapia)? () Sim () Não Você tem feito isso há mais de 6 meses? () Sim () Não	
Avaliação em Saúde Mental	
Você faz tratamento psicológico? () N () S, se sim, a quanto tempo: _____ Você sente necessidade de terapia? () N () S, se sim qual o motivo: _____ Percebe fatores psicológicos/psiquiátricos envolvidos no seu quadro de obesidade? : () N () S, se sim, quais? Você fez/faz tratamento psiquiátrico? () N () S, se sim, por quanto tempo	
Problemas de Saúde Diagnosticado	Presença de Problemas de Saúde
Apneia do Sono	() Sim () Não
Arritmia cardíaca/ Insuficiência cardíaca	() Sim () Não
Ansiedade	() Sim () Não
Depressão	() Sim () Não
Outro problema Psiquiátrico	() Sim () Não, se sim, qual?
Diabetes mellitus (DM) Tipo I ou II	() Sim () Não
Dislipidemia	() Sim () Não
Gastrite ou úlcera estomacal	() Sim () Não
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)	() Sim () Não
Hipotireoidismo	() Sim () Não
Algum problema de pele	() Sim () Não. Quais?
Outros problemas de saúde?	() Sim () Não. Quais?

Avaliação de Vida Diária		
Tem dificuldades em/na:		
Tomar banho ou higienizar-se? () Sim () Não. Quais?		
Secar todas as partes do seu corpo? () Sim () Não. Quais?		
Vestir-se? () Sim () Não. Quais?		
Colocar meias e calçados? () Sim () Não. Quais?		
Sentar-se e levantar-se do vaso sanitário? () Sim () Não		
Mobilidade? () Sim () Não, Qual apoio precisa?		
Qualidade do Sono		
Com que frequência você tem dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo? () Muito frequente () Frequentemente () Ocasionalmente () Raramente () Nunca		
Com que frequência você costuma acordar se sentindo descansado e revigorado na maioria das manhãs? () Muito frequente () Frequentemente () Ocasionalmente () Raramente () Nunca		
Você já foi diagnosticado com algum distúrbio do sono, como apneia do sono ou insônia? () não () sim, Se sim, qual? _____		
Você já notou alguma relação entre a qualidade do seu sono e o seu peso ou hábitos alimentares? () não () sim, Se sim, descreva? _____		
Listar Medicamentos de uso crônico: → Nome, concentração e frequência		
Nome	Concentração	Frequência
Observação geral:		

ANEXO 2

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Repercussões do itinerário terapêutico de pacientes com obesidade candidatos a cirurgia bariátrica em um hospital de ensino público na região oeste do Paraná.

Pesquisador: Allan Cezar Faria Araujo

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 83640824.4.0000.0107

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.470.688

Apresentação do Projeto:

Saneamento de pendências

Objetivo da Pesquisa:

Vide descrição anterior

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Vide descrição anterior

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Vide descrição anterior

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide descrição anterior

Recomendações:

O estudo apresentou a data de encerramento. Qual seja: A coleta de dados será realizada no período de março a maio de 2025.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Considerações Finais a critério do CEP:

O pesquisador deverá entregar o relatório Final, assim que concluir o estudo. A desistência do

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

CEP: 85.819-110

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

ANEXO 3



*Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP*



*Aprovado na
CONEP em 04/08/2009*

ANEXO I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Título do Projeto: Repercussões do itinerário terapêutico de pacientes com obesidade candidatos a cirurgia bariátrica em um hospital de ensino público na região oeste paranaense.

Pesquisador responsável e colaboradores com telefones de contato: Allan Cezar Faria Araújo, (45) 99973-0185 – José Joacy Rabelo de Oliveira, (45) 99968-0003.

Convidamos você a participar de nossa pesquisa que tem o objetivo de ouvir como você vê o seu tratamento para obesidade, desde quando começou a fazer até agora, para isso será realizado uma entrevista, onde você poderá falar tudo que desejar no que diz respeito ao seu tratamento para obesidade.

Durante a execução do projeto você poderá se deparar com alguma lembrança ruim que eventualmente tenha acontecido ao longo do tempo, enquanto buscava por atendimento em seu tratamento para obesidade. Para algum questionamento, dúvida ou relato de algum acontecimento os pesquisadores poderão ser contatados a qualquer momento. Saber se a quantidade de consultas, exames, a facilidade pra conseguir estes serviços e o tempo de demora desde o momento do início do tratamento até a espera pela cirurgia, poderiam nos ajudar a perceber como o seu tratamento aconteceu, se foi positivo ou negativo tudo que aconteceu e nos ajudar sobre a necessidade de melhorar o seu tratamento e ajudando outros a se beneficiar destas coisas. Este documento é entregue em duas vias, sendo que uma ficará com a pessoa que está fazendo essa pesquisa e a outra com você. Não é preciso pagar nada e nem receberá valores monetários por participar dela. É uma pesquisa sigilosa e as informações

ANEXO 4

WhatsApp | gov.br: Bloqueio de conta - | Caixa de entrada - emadtole - | Inbox - josejoacyrabelo@g... | Submissões | Sucupira - Portal Individual | +

rbone.com.br/index.php/rbone/submissions

RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e E... Tarefas 0 Português (Brasil) Ver o Site Josejoacy01

Submissões

Fila Arquivos Ajuda

Minhas Submissões Designadas

Buscar Nova Submissão

3353 JOSE JOACY RABELO OLIVEIRA, ARAÚJO, Ligiane, Rose Meire Costa
FRAGMENTAÇÃO, ESTIGMA E DESIGUALDADES: O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PE... Submissão

1 de 1 submissões

Platform & workflow by OJS / PKP

23°C Ensolarado Pesquisar 07:14 19/02/2026

ANEXO 5

Submissão de artigos para a Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento - RBONE.

O artigo submetido deve ser digitado em espaço duplo, papel tamanho A4 (21 x 29,7), com margem superior de 2,5 cm, inferior 2,5, esquerda 2,5, direita 2,5, sem numerar linhas, parágrafos e as páginas; as legendas das figuras e as tabelas devem vir no local do texto, no mesmo arquivo.

Formato dos arquivos

Para o texto, usar editor de texto tipo *Microsoft Word* para *Windows* ou equivalente, fonte arial, tamanho 12, as figuras deverão estar nos formatos JPG, PNG ou TIFF.

Artigo original

Um artigo original deve conter a formatação acima e ser estruturado com os seguintes itens:

Página título: deve conter,

- (1) O título do artigo, que deve ser objetivo, mas informativo;
- (2) Nomes completos dos autores; instituição (ões) de origem (afiliação), com cidade, estado e país, se fora do Brasil;
- (3) Nome do autor correspondente e endereço completo;
- (4) E-mail de todos os autores.

Resumo: deve conter,

- (1) O resumo em português, com não mais que 250 palavras, estruturado de forma a conter: introdução e objetivo, materiais e métodos, discussão, resultados e conclusão.
- (2) Três a cinco palavras chave. Usar obrigatoriamente termos do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS);
- (3) O título e o resumo em inglês (*abstract*), representando a tradução do título e do resumo para língua inglesa;
- (4) Três a cinco palavras chave em inglês (*key words*).

Introdução: deve conter (1) justificativa para o estudo, com referências pertinentes ao assunto, sem realizar uma revisão extensa e o objetivo do artigo de vir no último parágrafo.

Materiais e métodos: deve conter,

- (1) Descrição clara da amostra utilizada;
- (2) Termo de consentimento para estudos experimentais envolvendo humanos e animais, conforme recomenda as resoluções 466/12 e 510/16;
- (3) Identificações dos métodos, materiais (marca e modelo entre parênteses) e procedimentos utilizados de modo suficientemente detalhado, de forma a permitir a reprodução dos resultados pelos leitores;
- (4) Descrição breve e referências de métodos publicados, mas não amplamente conhecidos;
- (5) Descrição de métodos novos ou modificados;
- (6) Quando pertinente, incluir análise estatística utilizada, bem como os programas utilizados. No texto, números menores que 10 são escritos por extenso, enquanto que números de 10 em diante são expressos em algarismos arábicos.

Resultados: deve conter,

- (1) Apresentação dos resultados em sequência lógica, em forma de texto, tabelas e ilustrações; evitar repetição excessiva de dados e tabelas ou ilustrações e no texto;
- (2) Enfatizar somente observações importantes.

Discussão: deve conter,

- (1) Ênfase nos aspectos originais e importantes do estudo, evitando repetir em detalhes dados já apresentados na introdução e nos resultados;
- (2) Relevância e limitações dos achados, confrontando com os dados da literatura, incluindo implicações para futuros estudos;
- (3) Ligação das conclusões com os objetivos do estudo.

Conclusão: deve ser obtida a partir dos resultados obtidos no estudo e deve responder os objetivos propostos.

Referências: as referências devem ser escritas em sequência alfabética. O estilo das referências deve seguir normas da RBONE e os exemplos mais comuns são mostrados a seguir.

Exemplos:

- 1) Artigo padrão em periódico (deve-se listar todos os autores):

Amorim, P.A. Distribuição de Gordura Corpórea como Fator de Risco no Desenvolvimento de Doenças Arteriais Coronarianas: Uma Revisão de Literatura. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Londrina. Vol. . Num. 4. 1997. P. 59-75.

Autor institucional:Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Institui Diretrizes para Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de Educação Infantil, Fundamental e Nível Médio das Redes Pública e Privadas, em Âmbito Nacional. Portaria interministerial, Num 1010 de 8 de maio de 2006. Brasília. 2006.